

FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE

CONCOURS DE RESIDANAT 2025

Le cancer Broncho-pulmonaire

(Evaluation)

Pr Imen GARGOURI

1. Le cancer broncho-pulmonaire :
 - A. L'incidence chez la femme est en diminution depuis les années 1980
 - B. La 1^{ère} cause de mortalité par cancer chez l'homme
 - C. Exceptionnel chez le non fumeur
 - D. Responsable de 1,8 million de décès dans le monde en 2018
 - E. Evitable par le dépistage
2. Parmi les substances suivantes, quelles sont celles contenues dans le tabac et qui sont cancérogènes pour le poumon ?)
 - A- Phénol
 - B- hydrocarbures polycycliques
 - C- les nitrosamines
 - D- Isocyanates
 - E- Chrome
3. Parmi les produits à usage professionnel suivants, quels sont ceux incriminés dans la genèse du cancer bronchique ?
 - A. Silice
 - B. Mine d'uranium
 - C. Amiante
 - D. Talc
 - E. Radon
4. Les circonstances pathologiques suivantes peuvent être révélatrices d'un cancer du poumon :
 - A. une pleurésie transudative
 - B. une pneumonie récidivante
 - C. une pleurésie hémorragique
 - D. un pneumothorax
 - E. des convulsions
5. Parmi les éléments suivants, indiquer celui qui ne contre-indique pas la chirurgie en cas de CBNPC :
 - A. Extension tumorale à la veine cave supérieure
 - B. paralysie récurrentielle
 - C. adénopathie hilare
 - D. dysphagie
 - E. adénopathie sus claviculaire
6. Au cours d'un cancer du poumon la fibroscopie bronchique :
 - A. permet de visualiser une infiltration de la muqueuse
 - B. ne fait pas partie du bilan d'extension
 - C. peut être normale
 - D. permet de réaliser des prélèvements
 - E. est un examen capital pour le diagnostic
7. Le bilan d'extension d'un cancer bronchique à petites cellules comporte :
 - A. un scanner thoracique
 - B. une IRM thoracique
 - C. une biopsie ostéo-médullaire
 - D. une scintigraphie osseuse
 - E. une scintigraphie pulmonaire de perfusion

8. l'indication thérapeutique d'un cancer broncho-pulmonaire dépend:
- A. du type histologique
 - B. de l'âge chronologique
 - C. du terrain
 - D. du stade de la maladie
 - E. du taux des marqueurs tumoraux
9. Le bilan d'extension d'un cancer bronchique non à petites cellules comporte :
- A. une tomодensitométrie thoracique
 - B. une échographie abdominale
 - C. une scintigraphie pulmonaire
 - D. une tomодensitométrie cérébrale
 - E. une échographie cervicale
10. Le cancer bronchique à petites cellules :
- A. fait partie des tumeurs neuroendocrines
 - B. est traité chirurgicalement
 - C. est chimio sensible
 - D. est résistant à la radiothérapie
 - E. est le plus pourvoyeur des syndromes paranéoplasiques
11. La confirmation diagnostique d'un cancer bronchique peut se faire par :
- A. les marqueurs tumoraux
 - B. une biopsie bronchique
 - C. une ponction ou biopsie pleurale
 - D. une biopsie trans-thoracique
 - E. une thoracotomie
12. Le cancer bronchique primitif est :
- A. le cancer le plus fréquent chez l'homme
 - B. la première cause de mortalité par cancer chez l'homme
 - C. lié au tabagisme dans la moitié des cas
 - D. exceptionnel avant l'âge de 50 ans
 - E. latent souvent diagnostiqué à un stade avancé de la maladie.
13. Les signes endoscopiques suivants, sont évocateurs d'un cancer bronchique :
- A- un bourgeon tumoral endo-bronchique
 - B- une sténose d'un orifice bronchique
 - C- une infiltration de la muqueuse bronchique
 - D- une bronchomalacie
 - E- un saignement actif provenant d'un orifice bronchique
14. Le cancer bronchique à petites cellules :
- A. à un temps de dédoublement court
 - B. donne des métastases tardivement
 - C. est chimio sensible
 - D. est sensible à la radiothérapie
 - E. récidive fréquemment

Un homme âgé de 55 ans, fumeur 50 paquets années, consulte pour wheezing dyspnée laryngée, toux évoluant dans un contexte d'état général (amaigrissement de 5 kg en 4 mois). L'examen physique trouve une bouffissure du visage, avec comblement des creux sus claviculaires, circulation veineuse thoracique collatérale, la saturation en O₂ :98%
La radiographie du thorax de face montre une opacité latérotachéale droite à limites externes irrégulières (cancer bronchique très probable).

15. Les éléments de l'examen physique orientent vers :

- A. Une exacerbation de BPCO
- B. Un syndrome cave supérieur
- C. Une compression trachéale
- D. Une décompensation cardiaque
- E. Une crise d'asthme

16. Quel est l'examen à réaliser en première intention

- A. une recherche de BK dans les crachats
- B. **une fibroscopie bronchique**
- C. une ponction trans-thoracique sous scanner
- D. une échographie thoracique
- E. une IDR à la tuberculine

Le diagnostic d'un adénocarcinome a été confirmé par l'examen histologique

17. quels sont les examens à réaliser pour compléter le bilan d'extension :

- A. **une TDM thoracique**
- B. **une échographie abdominale**
- C. un dosage des marqueurs tumoraux
- D. **une TDM cérébrale**
- E. une spirométrie

18. la TDM thoracique a objectivé une tumeur du lobe supérieur droit de 6 cm de diamètre comprimant la veine cave supérieure et envahissant la trachée avec des ADNP sous carinaires la classification TNM sera :

- A. T3 N0 M0
- B. T4 N1 M1
- C. T2 N0 M0
- D. **T4 N2 M0**
- E. T3 N2 M1

19. Quel traitement proposez- vous pour ce malade :

- A. une chirurgie
- B. une chimiothérapie seule
- C. une radiothérapie exclusive
- D. **une radio- chimiothérapie**
- E. une chirurgie et une chimiothérapie adjuvante

CAS CLINIQUE n° 2

Un patient âgé de 65 ans, fumeur 50 PA, consulte pour une douleur scapulaire à irradiation thoracique postérieure avec paresthésie du MSG et un amaigrissement de 4 kg en 3 mois
L'examen physique trouve un ptosis et une enophtalmie gauche
La radiographie du thorax montre une opacité du 1/3 sup du poumon gauche

20. **Le tableau radio-clinique peut faire évoquer :**
- A. Une tuberculose pulmonaire
 - B. Un lymphome malin
 - C. Une tumeur de l'apex
 - D. Une aspergillose
 - E. Un Kyste hydatique du poumon
21. La fibroscopie bronchique montre une infiltration bourgeonnante de la lobaire supérieure droite, cet examen permet en plus de :
- A. Noter l'aspect des cordes vocales
 - B. Préciser la distance de la lésion par rapport à la carène
 - C. Faire des biopsies
 - D. Faire des cytologies à la recherche de cellules néoplasiques
 - E. Confirmer l'envahissement de la veine cave supérieure
22. **La biopsie de la lésion a mis en évidence un adénocarcinome bronchique, le bilan d'extension comporte :**
- A. Une IRM cervicothoracique
 - B. Un scanner cérébral
 - C. Un dosage des marqueurs tumoraux
 - D. Une échographie abdominale
 - E. Une scintigraphie pulmonaire
23. **L'examen thoracique a objectivé une tumeur de l'apex droit de 5 cm de diamètre sans extension vertébrale avec des ADNP hilaires homolatérales sous carinaires et controlatérales, la tumeur est ainsi classée :**
- A. T3N2M0
 - B. T3N1M0
 - C. T3N3M0
 - D. T4N3M0
 - E. T3N2M1
24. **L'attitude thérapeutique proposée sera :**
- A. Une chimiothérapie
 - B. Une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire
 - C. Une pneumonectomie droite
 - D. Une radiothérapie
 - E. Une association radiothérapie-chimiothérapie